

1. Introducción y relevancia clínica

La **artritis reumatoide (AR)** es una **enfermedad autoinmune sistémica, inflamatoria y crónica** que afecta principalmente las **articulaciones sinoviales**, provocando **sinovitis persistente, destrucción articular progresiva y discapacidad funcional**.

Es la **enfermedad reumatológica inflamatoria más frecuente** en adultos y una de las principales causas de discapacidad laboral en mujeres en edad media.

A nivel mundial, su prevalencia oscila entre **0,5 y 1%** de la población, con una **relación mujer:hombre de 3:1**. En Chile, según datos del MINSAL y la Sociedad Chilena de Reumatología (SOCHIRE), se estima una prevalencia cercana al **0,6%**, lo que representa decenas de miles de personas afectadas.

El diagnóstico y tratamiento precoz son fundamentales: la instauración del tratamiento dentro de los **primeros 3–6 meses desde el inicio de síntomas** reduce la progresión radiológica y mejora significativamente la calidad de vida.

En el **EUNACOM**, este tema es **de alta frecuencia**, con preguntas enfocadas en:

- Reconocimiento clínico (poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones).
- Marcadores inmunológicos (FR, anti-CCP).
- Principios del tratamiento (AINE, corticoides, DMARDs, biológicos).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La artritis reumatoide es una **enfermedad autoinmune mediada por linfocitos T y B** que genera inflamación crónica de la membrana sinovial.

2.1. Mecanismo inmunológico

1. **Predisposición genética:** asociación con el **HLA-DR4 y HLA-DR1**.
2. **Factores ambientales:** tabaquismo, infecciones virales (Epstein-Barr), microbiota intestinal alterada.

3. **Autoanticuerpos:** el sistema inmune produce **factor reumatoide (FR)** y **anticuerpos anti-péptidos citrulinados (anti-CCP)** que activan el complemento.
 4. **Sinovitis crónica:** los linfocitos T CD4+ y macrófagos liberan citocinas proinflamatorias (**TNF- α , IL-1, IL-6**) que estimulan la proliferación del sinoviocito tipo B, formando el **pannus**, tejido inflamatorio invasivo que destruye cartílago y hueso.
 5. **Destrucción articular y deformidad:** erosión ósea, anquilosis y pérdida funcional progresiva.
-

2.2. Factores de riesgo y desencadenantes

- Sexo femenino.
 - Edad entre 30–50 años.
 - Historia familiar de AR u otras enfermedades autoinmunes.
 - **Tabaquismo activo o pasado** (el principal factor ambiental conocido).
 - Infecciones periodontales (*Porphyromonas gingivalis*).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones articulares

Inicio: gradual, con rigidez matinal (>1 hora), dolor y tumefacción en articulaciones pequeñas y simétricas.

Distribución típica:

- **Interfalángicas proximales (IFP), metacarpofalángicas (MCF) y muñecas.**
- Menos frecuente en interfalángicas distales (IFD), lo que la diferencia de la artrosis.
- Afecta rodillas, tobillos y codos en fases avanzadas.

Características clínicas:

- Dolor articular inflamatorio (empeora en reposo, mejora con movimiento).

- Calor, tumefacción y limitación de movilidad.
- Rigidez matinal prolongada.
- Curso crónico con brotes y remisiones.

Deformidades típicas (etapas avanzadas):

- Desviación cubital de los dedos.
 - Cuello de cisne (hiperextensión IFP + flexión IFD).
 - Boutonnière (flexión IFP + hiperextensión IFD).
 - Subluxación atlantoaxoidea (riesgo en manipulación cervical anestésica).
-

3.2. Manifestaciones extraarticulares

Aunque la enfermedad es predominantemente articular, **hasta 40%** de los pacientes presentan compromiso sistémico:

- **Nódulos reumatoideos:** subcutáneos, firmes, indoloros, en superficies extensoras.
 - **Vasculitis reumatoide:** úlceras cutáneas, mononeuritis múltiple.
 - **Síndrome de Sjögren secundario:** xeroftalmía, xerostomía.
 - **Compromiso pulmonar:** nódulos, fibrosis intersticial o pleuritis.
 - **Cardíaco:** pericarditis, miocarditis.
 - **Hematológico:** anemia de enfermedad crónica, síndrome de Felty (AR + esplenomegalia + neutropenia).
 - **Ocular:** epiescleritis o escleritis.
-

3.3. Diagnóstico diferencial

1. **Artrosis:** dolor mecánico, rigidez breve, afecta IFD, sin signos inflamatorios.
2. **Artritis psoriásica:** lesiones cutáneas, compromiso asimétrico, dactilitis.

3. **Lupus eritematoso sistémico (LES):** artritis no erosiva, síntomas sistémicos, anticuerpos antinucleares positivos.
4. **Gota o pseudogota:** monoartritis aguda, cristales en líquido sinovial.
5. **Espondiloartritis:** compromiso axial, HLA-B27 positivo.

Comentario EUNACOM:

El patrón **poliartritis simétrica de manos y muñecas con rigidez matinal >1 hora** es prácticamente diagnóstico de **AR** en preguntas de examen.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Laboratorio

- **Velocidad de sedimentación globular (VSG) y proteína C reactiva (PCR):** elevadas.
 - **Factor reumatoide (FR):** positivo en 70–80%.
 - **Anticuerpos anti-CCP:** alta especificidad (>95%), detectables antes de los síntomas.
 - **Hemograma:** anemia normocítica normocrómica, trombocitosis reactiva.
 - **Bioquímica:** aumento de transaminasas o creatinina si hay toxicidad medicamentosa.
-

4.2. Imágenes

- **Radiografía de manos y pies:** erosiones marginales, pérdida de espacio articular, osteopenia yuxtaarticular.
 - **Ecografía articular:** detecta sinovitis precoz.
 - **RM:** útil en etapas iniciales para ver inflamación sinovial y daño óseo incipiente.
-

4.3. Criterios diagnósticos ACR/EULAR 2010

Para el diagnóstico se requiere un **puntaje $\geq 6/10$** considerando:

1. **Número de articulaciones comprometidas.**
 2. **Serología (FR, anti-CCP).**
 3. **Marcadores inflamatorios (VSG, PCR).**
 4. **Duración de síntomas (>6 semanas).**
-

5. Tratamiento (según MINSAL 2023 y guías internacionales EULAR/ACR 2024)

El objetivo terapéutico es lograr **remisión clínica o baja actividad inflamatoria** lo antes posible (“**tratamiento dirigido a la meta**”).

5.1. Medidas generales

- Educación del paciente y familia.
 - Suspensión del tabaco.
 - Ejercicio físico moderado y fisioterapia.
 - Apoyo psicológico.
-

5.2. Tratamiento farmacológico

A. Fármacos sintomáticos

- **AINEs:** alivian dolor e inflamación (ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco).

No modifican la progresión de la enfermedad.

- **Corticoides:** prednisona 5–10 mg/día o equivalentes como terapia puente mientras actúan los fármacos modificadores (DMARDs).
-

B. Fármacos modificadores de la enfermedad (DMARDs)

Son la base del tratamiento y deben iniciarse precozmente (ideal <6 meses del inicio de síntomas).

1. Metotrexato (MTX): fármaco de primera elección.

- Dosis inicial: 7,5–15 mg/semana VO o SC.
- Asociar **ácido fólico 5 mg/semana**.
- Control: hemograma, TGO/TGP, creatinina.

2. Alternativas o combinaciones:

- Leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina.
- En casos refractarios, combinar varios DMARDs (“triple terapia”).

3. Biológicos (si falla tratamiento convencional):

- Anti-TNF (etanercept, adalimumab, infliximab).
- Anti-IL6 (tocilizumab).
- Anti-CD20 (rituximab).
- Inhibidores JAK (tofacitinib, baricitinib) en casos seleccionados.

Comentario EUNACOM:

El **metotrexato** es siempre la **primera línea** de tratamiento modificador, salvo contraindicación.

C. Control de comorbilidades

- Osteoporosis: suplemento de calcio, vitamina D y bifosfonatos.
- Riesgo cardiovascular aumentado: control estricto de HTA, dislipidemia, DM2.
- Vacunación: antineumocócica e influenza antes de biológicos.

6. Complicaciones

- **Articulares:** deformidades irreversibles, anquilosis, pérdida funcional.
 - **Extraarticulares:** nódulos, vasculitis, pleuritis, pericarditis.
 - **Terapéuticas:** hepatotoxicidad (MTX, leflunomida), citopenias, infecciones (biológicos).
 - **Cervicales:** subluxación atlantoaxoidea (riesgo de compresión medular).
-

7. Pronóstico

La artritis reumatoide es una enfermedad **crónica e incurable**, pero **controlable**.

El pronóstico ha mejorado drásticamente con el uso de DMARDs y biológicos, logrando remisión sostenida en hasta **60% de los pacientes** tratados precozmente.

Factores de mal pronóstico:

- FR y anti-CCP positivos en altos títulos.
 - Afectación temprana de múltiples articulaciones.
 - Elevada PCR persistente.
 - Presencia de nódulos reumatoideos o manifestaciones extraarticulares.
-

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. La **rigidez matinal prolongada (>1 hora)** distingue AR de artrosis.
2. El **metotrexato** es el DMARD de elección inicial.
3. Los **anticuerpos anti-CCP** son los más específicos.
4. Los **AINEs y corticoides** sólo alivian síntomas, no modifican la evolución.
5. La **radiografía de manos y pies** es fundamental para control evolutivo.

6. En pacientes con fiebre o infección activa, **suspender biológicos**.
7. En el EUNACOM, las preguntas suelen orientarse al tratamiento inicial o a la interpretación clínica típica (poliartritis simétrica).

Errores comunes:

- Retrasar el inicio de DMARDs esperando confirmación serológica.
 - No suplementar ácido fólico con metotrexato.
 - Usar AINEs como tratamiento principal.
 - Ignorar la necesidad de vacunación antes de biológicos.
 - No solicitar radiografía inicial de manos y pies.
-

9. Resumen final (6 ideas clave)

1. La **artritis reumatoide** es una **enfermedad autoinmune inflamatoria crónica** que afecta principalmente las articulaciones pequeñas y simétricas.
2. Su **diagnóstico es clínico**, apoyado por **FR, anti-CCP y elevación de reactantes de fase aguda**.
3. El **metotrexato** es el **tratamiento modificador de primera línea**.
4. Los **biológicos** se indican en casos refractarios o graves.
5. La **detección precoz y control estrecho** evitan la discapacidad.
6. En **EUNACOM**, los aspectos más preguntados son:
 - Clínica típica (poliartritis simétrica + rigidez matinal).
 - Primer DMARD (metotrexato).
 - Marcador más específico (anti-CCP).